六、慢性淋巴细胞性/自身免疫性甲状腺炎/桥本

很多纤维化

①甲状腺双侧弥漫肿大、质地坚韧，广泛滤泡被破坏、伴大量淋巴细胞浸润和淋巴滤泡

②**甲减**的表现：BMR、T_3、T_4、摄碘率均↓ VS 亚甲炎(部分滤泡被破坏,就会有分离现象)

③**TPOAb**（90%）、TGAb（60%）等

④治疗：甲状腺素

七、甲状腺结节

	恶性可能大	良性可能大
年龄性别	儿童（50%为恶性）、年轻男性	女性
数目	**单发**	多发
迅速增大	**可（无痛）**	少见，但**腺瘤囊性变伴囊内出血可、胀痛**
颈部淋巴结肿大	**多有**	多无
TSH	↑会促进分化型甲状腺癌生长	正常或↓(高功能腺瘤)
核素	冷结节（功能低下）、血供丰富、边缘模糊	热、温、冷结节均可有

注意：**TG** 与甲状腺结节的良恶性**无**关；TSH 与甲状腺结节的良恶性有关

八、甲状腺相关疾病的手术（I类清洁切口）

1.指征：**恶变如沙粒样钙化、高功能腺瘤、中重度原发性甲亢（BMR＞30%）、结甲等继发性甲亢、胸骨后甲状腺肿、甲状腺显著肿大有压迫症状**（我高中姐凶呀）eg.压迫气管出现呼吸困难

注意：妊娠期手术时机为妊娠**中**期（4-6 月）有手术适应症、且无手术禁忌症时（早晚要出事）

2.术后并发症

（1）甲状腺危象

①**甲亢术前准备不充分**（最主要）、甲亢治疗不当、**感染**、精神因素等应激

②高热大汗、上吐下泻、谵妄昏迷

③**PTU（首选）**、碘剂、普萘洛尔、氢化可的松、物理降温（**禁用阿司匹林**）别合成、别释放、别来刺激我心脏



①致游离TH增多②致大量出汗加重脱水

提高应激能力

（2）呼吸困难和窒息（最严重）

①**出血压迫气管：切口渗血、饱满。立即床旁抢救：拆线敞切口、止血清血肿**，即使止血充分也应放 ttsx 引流

②气管软化塌陷：术前应颈部摄片 气管长期受到肿大甲状腺压迫,气管软骨软化。切除甲状腺后,气管容易坍塌,因为甲状腺没切前对气管有牵拉作用。

③喉头水肿：手术创伤、气管插管所致

④**双**侧喉**返**神经损伤 两侧声带动不了→声门就完全关掉→窒息

⑤误切甲状旁腺 →甲状旁腺激素↓(升钙降磷)→血钙↓→膜屏障作用↓→阈电位和膜电位距离变近→兴奋性↑→低钙惊厥低钙抽搐→呼吸肌抽搐→呼吸困难窒息

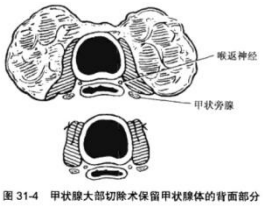


图 31-4 甲状腺大部切除术保留甲状腺体的背面部分

（3）神经损伤

喉**上**神经**内**支	**饮水呛咳**（喉黏膜感觉异常）	喝水向里面
喉**上**神经**外**支	**音调降低**（环甲肌瘫痪、声带松弛）	说话向外面
一侧喉**返**神经	声音**嘶哑**	一侧嘶
双侧喉**返**神经	**失声、呼吸困难** 声门完全关闭发生窒息	双侧死
颈交感神经	**Horner 综合征（眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、额面部胸壁无汗）**	wink

交感N-发汗

下丘脑**腹内**侧核	**饱食**中枢（拒食）（内）（注意题干问刺激还是破坏）
下丘脑**外**侧区	**摄食**中枢、**摄水**中枢（**渴觉**中枢）（外面摄入）